

48 - 01-Les vomissements - Pr K. KRATI

Les vomissements sont des motifs de consultation assez fréquents et peuvent être secondaires à des pathologies variables et peuvent être aussi de pronostics variables. Ainsi, le tubule doit être capable de reconnaître les vomissements et de les distinguer de tout ce qui n'est pas vomissement et doit préciser les caractères et surtout identifier les complications et les facteurs de gravité de ces vomissements et être capable de mener une enquête étiologique basée sur la clinique pour augmenter son diagnostic étiologique et reconnaître les causes les plus urgentes et qui engagent le pronostic vital. Les vomissements représentent l'un des motifs de consultation les plus fréquents.

Leur diagnostic reste clinique, ne justifie aucun examen complémentaire pour les confirmer. Et devant des vomissements, il est capital de rechercher les signes en faveur d'une étiologie qui peut être grave et nécessitant une prise en charge en extrême urgence. Bien sûr, devant des vomissements chroniques et répétitifs, il faut toujours rechercher des complications et des retentissements de ces vomissements.

Ils sont secondaires à de multiples affections. Certains sont digestifs, d'autres sont extradigestifs, ce qui amène à réaliser devant des vomissements une enquête étiologique bien codifiée et structurée basée sur l'examen clinique. Avant de parler de diagnostic et de l'enquête étiologique de vomissements, il est capital de rappeler la physiopathologie.

En effet, le centre de vomissement est situé au niveau de planchers du quatrième ventricule. Ce centre de vomissement peut être stimulé soit par des stimulus ou des messages sensitifs qui proviennent de récepteurs au niveau du pharynx, au niveau du tube digestif, au niveau du péritoine, au niveau des voies biliaires, au niveau des coronaires, des testicules, de l'appareil vestibulaire. Ce qui explique les vomissements qui surviennent dans des pathologies qui peuvent être extradigestives.

Il est aussi sous la dépendance du cortex, du thalamus et de l'hypothalamus. Là aussi, ça explique la stimulation de ce centre en cas de dégoût. Par exemple, le malade qui vomit quand il voit quelque chose qui le dégoûte.

Lorsqu'il est dans une situation de stress, il peut vomir. Donc, ça explique parce que ce centre est aussi sous la dépendance du cortex cérébral. Il y a aussi des stimulus qui proviennent de certains récepteurs périphériques, des stimulus chimiques.

C'est pour ça qu'on peut avoir en cas de certains troubles ioniques comme l'hypercalcémie, comme l'hypertyroïdie par exemple lorsqu'on a une augmentation de TSH, lorsque par exemple on a une insuffisance surrénale lorsqu'on a une hypercalcémie ou parce que lorsque le malade prend certains médicaments qui peuvent être à l'origine d'une stimulation. Le centre de vomissement peut être stimulé par trois mécanismes, soit de façon sensitive, c'est à travers les

récepteurs qui sont situés dans différents organes, soit directement par le système nerveux, le cortex, le thalamus ou l'hypothalamus, par des stimulus chimiques. Lorsque ce centre est stimulé, il va entraîner, il va envoyer des afférentes vers les muscles abdominaux, vers la musculature gastrique, le pylore et le cardia et aussi vers les muscles intercostaux, ce qui va entraîner des contractions des abdominaux avec fermeture du pylore et une contraction rétrograde de l'estomac.

Il va envoyer des thalamus vers l'œsophage avec un relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage avec une contraction des intercostaux. Tout cela va aboutir à une élimination du contenu gastrique par la bouche après cet effort et cette contraction musculaire. Devant des vomissements, il faut éliminer tout ce qui n'est pas vomissement, bien sûr, et parallèlement, il faut évaluer la gravité de ces vomissements et mener une enquête étiologique pour pouvoir proposer un traitement spécifique.

Pour le diagnostic positif, il est facile devant le rejet par la bouche du contenu gastrique ou gastro-duodénal après contraction du diaphragme et des muscles de la paroi abdominale. Vous voyez, il y a cet effort de vomissement. Ce vomissement peut aussi s'accompagner de nausées qui peuvent être une sensation subjective, désagréable, qui est non douloureuse, qui s'accompagne de l'envie de vomir et qui peut se terminer par le vomissement ou parfois il ne se termine pas par les vomissements et qu'il doit faire rechercher aussi les mêmes étiologies que les vomissements.

Les vomissements peuvent aussi s'accompagner de certains signes sympathiques et parasympathiques, de les différencier des régurgitations et des myrcysmes. Les régurgitations, c'est aussi la remontée passive, la remontée dans la bouche du contenu gastrique ou œsophagien, mais de façon passive. Cela se voit dans le reflux gastro-œsophagien.

Cette remontée passive, l'absence de la contraction, de l'effort, permet de faire le diagnostic différentiel. Le myrcysme, qu'on appelle aussi l'érumination, c'est la remontée volontaire par la pression du contenu gastrique dans la bouche, qui va être encore une fois mastiquée et avalée. Le myrcysme, on le voit chez les animaux comme la vache, le chameau.

Chez l'être humain, ça témoigne d'un trouble psychologique ou psychiatrique. Ce n'est pas la même chose, il n'y a pas cet effort de vomissement, ce qui fait la distinction entre les deux. Une fois le diagnostic positif, il faut toujours évaluer la gravité de vomissement.

Il faut toujours considérer grave les vomissements hémorragiques, c'est-à-dire les hématemèses, ou lorsqu'on a des signes de retentissement, c'est-à-dire c'est un vomissement chronique qui va s'accompagner des signes de déshydratation, du polyvolimie, etc., ou de complications mécaniques qu'on ne voit pas au cours du cours. Et parallèlement à l'évaluation de la gravité, il faut mener une enquête étiologique. Dans tout vomissement, il faut rechercher les critères de gravité.

D'abord, le terrain. Chez un sujet âgé, les vomissements peuvent le fragiliser et donc il faut rapidement identifier la cause pour traiter de façon spécifique. Les vomissements, lorsqu'il survient chez un sujet qui est porteur d'une maladie, leur prise en charge doit être rapide.

Le deuxième critère aussi, c'est le retentissement des vomissements. Ça se voit surtout lorsqu'on a des vomissements très importants, itératifs et chroniques. Ça peut entraîner une polyurie ou une déshydratation.

Ça peut aussi entraîner des troubles hydroélectrolytiques, notamment une hypocalcémie, une hyponatrémie ou une hypocalcémie. Lorsqu'ils sont prolongés, ils peuvent s'accompagner aussi de dénutrition. Pour cela, il faut donc faire un examen à la recherche des signes de déshydratation et un bilan complémentaire, un ionogramme sanguin avec une fonction rénale.

Il y a aussi des critères de gravité qui sont liés à l'étiologie elle-même. Déjà, il y a des signes abdominaux qu'il faut absolument rechercher. Il faut rechercher si le patient présente des signes en faveur d'une péritonite, par exemple une contracture abdominale, des signes en faveur d'une occlusion à l'arrêt des matières et des gaz.

Il faut rechercher aussi une hernie étranglée, un kyste ovarien étranglé ou rompu. À côté des signes abdominaux, il ne faut pas oublier les signes neurologiques parce que les vomissements peuvent aussi être secondaires à un syndrome d'hypertension intracrânienne. Donc, il faut rechercher des céphalées importantes.

Il faut rechercher des signes déficitaires, notamment une épilepsie, une diminution de la motricité ou de la sensibilité. Il faut évaluer l'état en fonction du patient. Il faut rechercher un syndrome méningé.

Donc, leur présence constitue une urgence aussi étiologique et diagnostique. Il faut rechercher aussi des signes en rapport avec une cause métabolique urgente, notamment des signes d'insuffisance rénale. Par exemple, un patient qui est sous corticothérapie de forte dose et de façon prolongée, arrêté brutalement, un patient qui a une asthénie profonde.

Il faut penser aussi à un hyperthyroïdisme, surtout chez un patient qui présente une irritabilité, un insomnie, un amaigrissement, une diarrhée, des tremblements. Donc, il faut penser à demander le test T pour voir s'il est effondré ou non. Parallèlement à ce diagnostic de gravité, il faut faire une enquête étiologique.

Parallèlement à l'évaluation de la gravité de ces vomissements, l'enquête étiologique est démarrée. Il repose sur l'examen clinique qui va rechercher des signes en faveur d'une étiologie et aussi rechercher des signes en faveur d'une complication de ces vomissements. Pour l'interrogatoire, il doit toujours préciser les caractères des vomissements, en particulier l'aspect des vomissements.

Est-ce que les vomissements sont alimentaires, fécaloïdes ou sanglants ? Lorsqu'on est devant des vomissements fécaloïdes, il faut craindre une occlusion négligée qui serait à l'origine de ces vomissements et qu'il faut prendre en urgence. Lorsque les vomissements sont sanglants, c'est des hématomés, il faut rechercher une lésion hémorragique au niveau de tractus digestif. Il faut préciser le nombre de vomissements par jour.

Il faut rechercher si c'est matineux, que ce soit essentiellement chez les patients éthyliques. Est-ce que ce sont des vomissements postprandiaux ? Est-ce qu'ils sont postprandiaux précoces ou tardifs ? Attention, devant des vomissements postprandiaux tardifs, attention, il faut penser à une sténose antrypylorique, en particulier si cette sténose soulage une douleur postprandiale tardive. Il faut rechercher le contexte.

Est-ce qu'ils sont spontanés ou provoqués ? J'insiste sur le provoqué. Parfois, chez les patients qui ont une sténose antrypylorique, ils peuvent avoir des douleurs à titre d'épigastrie apesanteur postprandiale tardive qui vont être soulagées par les vomissements, ce qui va amener le malade à vomir chaque fois qu'il a ces douleurs. C'est un signe en faveur de la sténose antrypylorique.

Il faut toujours préciser est-ce que le malade a des vomissements, est-ce qu'il évolue plus de 7 jours ou moins pour dire est-ce que c'est des vomissements aigus ou chroniques. Toujours, il faut préciser le terrain et le contexte. Est-ce que le malade prend des médicaments ? Il faut faire un listing des médicaments que prend le patient.

Il faut aussi rechercher la notion d'une chirurgie antérieure. Il y a certaines pathologies, par exemple, une chirurgie pour un cancer, ça doit faire craindre une récurrence ou une évolutivité de la maladie. Il faut aussi rechercher les antécédents chirurgicaux parce qu'il y a des occlusions sur le long qui peuvent aussi compliquer, qui peuvent aussi se manifester par des vomissements.

Il faut rechercher, comme je l'ai dit, la prise médicamenteuse mais aussi les habitudes toxiques. Il faut rechercher l'usage. Il faut rechercher un contexte infectieux.

Il faut rechercher les immunodépresseurs, la chémo, le diabète. Il faut rechercher des antécédents traumatismes crâniens parce qu'un traumatisme crânien peut parfois se compliquer par un hématome qui peut être ou une hémorragie qui peut être à l'origine d'un syndrome d'hyperfonction crânien avec vomissement un petit peu plus tardive par rapport à la survenue du traumatisme. Il faut préciser les signes digestifs, notamment s'il y a des troubles de transit, s'il y a des douleurs abdominales, s'il y a des arrêts des matières et des gaz.

Je m'arrêterai au niveau des arrêts des matières et des gaz. Vomissement plus arrêt des matières et des gaz doit faire suspecter une occlusion et donc rechercher cette occlusion et la prendre en charge. Il faut toujours préciser les signes extra digestifs.

Est-ce que ce vomissement survient dans un contexte d'altération de l'état général ? C'est en

faveur de l'organicité des vomissements. Est-ce qu'il y a un contexte infectieux parce que les vomissements font partie du syndrome infectieux? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a un syndrome psédophilippal? Est-ce que le malade a un foyer, une porte d'entrée, notamment une atteinte, une otite par exemple, un foyer ORL? Est-ce qu'il a une infection urinaire? Est-ce qu'il a des brûlures lictionnelles? Est-ce que les urines sont en trouble? Est-ce qu'il a une lésion cutanée infectée? Est-ce qu'il y a un abcès quelque part? Est-ce qu'il y a une douleur lancinante quelque part au niveau de sang? Donc, il faut rechercher un foyer infectieux. Il faut aussi faire un examen neurologique complet avec recherche des signes neurologiques déficitaires, une hémiplégie par exemple, une paraplégie, une diminution de la motricité, une anomalie de la sensibilité, des vertiges, des céphalées.

Ça c'est important, ça oriente vers une origine neurologique. Il faut rechercher les signes gynécologiques urinaires. Les signes gynécologiques chez la femme, il faut préciser la date des dernières règles parce qu'il peut s'agir d'une grossesse extra-utérine qui est une urgence.

Il peut aussi être en rapport avec un test ovarien rompu ou tordu. Il faut rechercher les signes respiratoires, notamment une pneumopathie infectueuse. Et l'examen doit rechercher des signes en faveur d'un retentissement, d'évomissement, notamment une hypotension, une déshydratation, des signes en faveur d'une hypocalémie, notamment des crampes musculaires ou des troubles d'oeufs.

L'examen physique doit préciser les constantes vitales. L'état de conscience du patient doit préciser sans point s'il y a des signes de déshydratation ou d'hypotension. Il doit rechercher une hyper-indiabète par les bandelettes urinaires.

L'examen abdominal doit rechercher s'il y a une douleur provoquée abdominale qui peut orienter vers une masse ou un foyer infection. Il doit rechercher une défense, une contracture. Il doit examiner les fosses lombaires pour rechercher s'il y a une défense parfois, une litiase urinaire enclavée pour être à l'origine d'une illuse qui peut s'accompagner d'évomissements, de défenses, de contractures.

Donc il faut rechercher une masse abdominale. Il faut faire un examen des aires ganglionnaires. Les aires nids peuvent se trangler et si on ne les prend pas en charge ils peuvent donc se nécroser et se compliquer.

Et bien sûr il faut faire un examen abdominal neurologique avec un fond d'œil à la recherche des signes d'hypertension intracrânienne. Il faut faire un examen cardiovasculaire, fluoropulmonaire, un examen des cutanées. Il faut faire un examen ostéo-articulaire donc avec examen des aires ganglionnaires.

Les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Nous serons demandé que devant des vomissements récidivants ou lorsque l'interrogatoire retrouve une étiologie, à ce moment-là ils vont être étiologisés, orientés par les données de l'examen clinique ou lorsqu'on suspecte une

complication. Pour les étiologies, j'ai mis cette plaque avant de donner tous les étiologies pour préciser à quoi il faut penser en urgence devant des vomissements.

D'abord il faut éliminer les urgences chirurgicales, à savoir une péritonite, c'est la douleur, l'abdomen plat, donc la contracture. Il faut penser à l'occlusion, l'arrêt des matières et des gaz, les vomissements, la douleur abdominale, le ballonnement, l'appendicite, l'infarction du myocarde, c'est la douleur abdominale intense avec un abdomen où il n'y a pas de défense ni de contracture. Il faut aussi rechercher les urgences gynécologiques, notamment la grossesse extra-utérine, donc il faut y penser souvent à une jeune patiente avec un retard des règles, avec des métrorragies.

Il faut penser à une ponction d'un kystovarien. Il y a aussi les urgences virologiques, notamment l'infection urinaire, ou une lithiase enclavée, il faut rechercher colique néphritique. Il faut rechercher aussi les urgences neurologiques, donc à l'examen il faut rechercher un syndrome méningé, il faut rechercher des signes déficitaires, des signes d'hypertension intracrânienne, notamment des sépalées.

Et il y a aussi des urgences médicales qu'il ne faut pas oublier, à savoir l'infarctus de myocarde, il faut toujours y penser. Chez un patient par exemple qui a des antécédents ou des facteurs de risque d'infarctus de myocarde, c'est-à-dire un patient tabagique, éthylique, un patient qui souffre des insuffisances coronariennes, donc ces douleurs thoraciques déclenchées par la douleur et qui peuvent, par l'effort qui est radié vers l'épaule gauche, il faut, chez les patients aussi diabétiques, il faut penser à l'infarctus de myocarde. Les patients aussi hypertendus, etc., et demander éventuellement un usage.

Il ne faut pas oublier les causes métaboliques qui peuvent être graves comme l'hypercalcémie, la cytose diabétique, l'infusion sérolytique aiguë. C'est pour ça qu'il faut demander une calcémie, une glycémie et un ionogramme sanguin. Il faut penser aux intoxications médicamenteuses, donc il faut faire un listing de tout ce que prend le patient.

Maintenant pour les étiologies, on distingue les étiologies liées à un vomissement aiguë, notamment qui peut être de causes digestives, notamment les urgences chirurgicales, l'ulcère gastro-duodénal, les gastro-entérites, la toxi-infection. On a les vomissements aiguës extra-digestifs, les causes médicamenteuses, l'intoxication alcoolique aiguë, les causes neurologiques. On a aussi les causes métaboliques, la cytose diabétique, l'infusion sérolytique, l'hypercalcémie, l'infusion sérolytique.

Il y a aussi l'hypertension. Les autres causes, le mal de transport, la torsion d'un tisse de l'ovaire. On a les causes chroniques, soit liées à une obstruction de tractus digestif.

J'insiste sur l'asténose entéro-pulvoro-vulvaire qui se manifeste par des vomissements post-prandial tardifs, parfois provoqués sous l'agent des douleurs post-prandiales tardives. On a les causes

digestives non obstructives, c'est les ulcères gastro-diurnaux, les pancréasites chroniques, la gastroparesie, l'absurde obstruction intestinale chronique, la fustule gastropilonique, le syndrome de Zollinger. Pour ce qui est extra-digestif, des vomissements chroniques, on a la grossesse, il faut toujours y penser, les causes médicamenteuses, les causes neurologiques et les vomissements psychogènes.

Avant de terminer, je rappelle les complications des vomissements qu'il faut toujours rechercher, c'est les troubles électrolytiques qui se voient lorsqu'on a des vomissements abondants et répétés. Ils s'accompagnent à l'origine d'une déshydratation globale ou extracellulaire. On peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle avec des troubles ioniques à type d'hypokaliémie, hypochlorémie, arthralgie métabolique et dénutrition.

Les complications respiratoires sont liées surtout à l'inhalation et donc le malade peut faire des pneumopathies d'inhalation. On a les complications mécaniques, j'insisterai sur le syndrome de Mallory-Weiss qui prévient des complications mécaniques. C'est une rupture, donc c'est une ulcération au niveau du cardia, secondaire à l'effort des vomissements et qui peut entraîner des hématemés.

Les autres complications mécaniques, notamment la rupture spontanée du zone phage, l'hématome intramurales, sont rares. Il y a aussi le risque de la charge de suture chez les patients qui ont récemment été opérés. Pour conclure, je dirais que les vomissements doivent s'accompagner de façon, après le diagnostic parallèle d'évaluation de la gravité et la recherche de complications pour les prendre en charge, parallèlement à l'enquête étiologique qui doit préciser les caractères de vomissements et préciser les signes associés et le contexte de survenue.

Ceci permettra d'orienter le diagnostic vers une hypothèse étiologique qui va être confirmée par les examens complémentaires. En absence d'orientation, à ce moment-là, il faut voir les caractères des vomissements. S'il s'agit d'un seul épisode ou des vomissements qui sont aigus, il faut surveiller le patient.

Si ses vomissements sont récidivants ou chroniques, à ce moment-là, il faut rechercher une cause organique et faire les bilans nécessaires. Je vous remercie.